Dialýza a konzervatívna starostlivosť u starších pacientov v štúdii Prepare for Kidney Care

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 08.11.2026



Ilustračná poloschematická scéna spoločného rozhodovania o liečbe. Nezobrazuje konkrétneho pacienta ani konkrétny zdravotnícky výrobok a nevyjadruje prevahu jednej stratégie.

Pri rozhodovaní o liečbe staršieho človeka so zlyhaním obličiek nemá byť príprava na dialýzu automatickou voľbou. Nová randomizovaná štúdia Prepare for Kidney Care poskytuje podklad na spoločné zvažovanie dialyzačnej a konzervatívnej stratégie. Nepreukázala však ich rovnocennosť ani to, že dialýza u starších ľudí nepredlžuje život. Porovnávala dva spôsoby prípravy a poskytovania starostlivosti ešte pred začatím dialýzy. Tento rozdiel je rozhodujúci pre interpretáciu výsledkov. [1, 6]

Správa News-Medical upozornila na výsledky publikované 4. novembra 2026 v časopise The Lancet. Jej hlavné posolstvo, potreba individuálneho rozhodovania, je klinicky relevantné. Formuláciu, že konzervatívny postup neskracuje život ani nezhoršuje jeho kvalitu, však treba čítať opatrnejšie: neprítomnosť štatisticky významného rozdielu v skúške superiority nie je dôkazom ekvivalencie. [1, 8]

Koho štúdia skutočne zahŕňala

Do pragmatického, otvoreného randomizovaného skúšania v 31 britských nefrologických centrách bolo zaradených 445 účastníkov. Medián veku bol 82 rokov a 137 účastníkov, teda 31 %, tvorili ženy. Podmienkou bola odhadovaná glomerulová filtrácia pod 15 ml/min/1,73 m², potvrdená ďalším meraním v predchádzajúcich 12 mesiacoch a nevysvetlená akútnym poškodením obličiek. [1]

Pacienti vo veku aspoň 80 rokov mohli byť zaradení bez ďalšej podmienky krehkosti či komorbidity. Vo veku od 65 do 79 rokov museli mať funkčný stav podľa WHO aspoň 3 alebo Daviesovo skóre komorbidity aspoň 2. Výsledky preto nemožno vzťahovať na všetkých ľudí nad 65 rokov s chronickou chorobou obličiek ani stotožňovať vysoký vek s krehkosťou. [1]

Publikovaný protokol navyše vylučoval pacientov nespôsobilých na dialýzu, tých, ktorí ju podľa klinického posúdenia potrebovali do štyroch týždňov, a osoby neschopné poskytnúť informovaný súhlas. Vylúčená bola aj

predchádzajúca transplantácia a aktívne transplantačné vyšetrenie alebo zaradenie na čakaciu listinu. Nešlo teda o porovnanie urgentnej dialýzy s jej neposkytnutím ani o štúdiu výberu liečby u všetkých pacientov s pokročilou demenciou. [2]

Dve stratégie, nie dve skupiny podľa prijatej dialýzy

Na prípravu konzervatívnej stratégie bolo randomizovaných 228 účastníkov a na prípravu dialyzačnej stratégie 217. Konzervatívna vetva používala protokolizovanú starostlivosť označenú ako responsive management: liečbu zameranú na potreby pacienta, kontrolu príznakov, spomaľovanie progresie a zachovanie kvality života bez dialýzy a transplantácie. Dialyzačná vetva predstavovala prípravu na prípadné začatie dialýzy podľa následného klinického vývoja a spoločného rozhodnutia. [1, 2]

Zaradenie do dialyzačnej vetvy neznamenalo okamžité začatie liečby. Protokol umožňoval účastníkom zmeniť pôvodne zvolenú stratégiu a pokračovať v sledovaní. Hlavná analýza výsledkovej publikácie hodnotila pacientov podľa randomizovaného priradenia, nie iba podľa toho, či nakoniec absolvovali dialýzu. Odpovedá preto predovšetkým na otázku, aké dôsledky má príprava jednej alebo druhej stratégie v skúmanej populácii. Neizoluje biologický účinok dialýzy u pacientov, ktorí ju skutočne potrebujú. [1, 2]

Primárny výsledok spájal dĺžku a kvalitu života

Primárnym ukazovateľom boli roky života upravené o kvalitu, QALY, vypočítané zo sledovaného prežívania a pacientom hodnoteného zdravotného stavu pomocou EQ-5D-5L. QALY nie je samotná dĺžka života ani jednoduché skóre spokojnosti s liečbou. Úmrtie a zmeny kvality života sa premietajú do spoločného ukazovateľa. [1, 2]

Pri priemernom sledovaní 4,5 roka dosiahla konzervatívna vetva priemer 1,354 QALY a dialyzačná vetva 1,472 QALY. Upravený priemerný rozdiel, počítaný ako konzervatívna stratégia mínus dialyzačná stratégia, bol -0,147 QALY s 95 % intervalom spoľahlivosti od -0,350 do 0,056; p = 0,16. Upravený rozdiel sa nesmie zamieňať za jednoduchý rozdiel uvedených neupravených priemerov. [1]

Štúdia nezistila dôkaz superiority jednej stratégie. Interval spoľahlivosti však pripúšťa aj klinicky podstatné znevýhodnenie konzervatívnej stratégie v primárnom ukazovateli. Na záver o ekvivalencii alebo noninferiorite by bol potrebný zodpovedajúci dizajn, vopred určená hranica a jej splnenie. Výsledok preto nemožno preložiť vetou, že oba postupy poskytujú zaručene rovnakú dĺžku a kvalitu života. [1]

Počas sledovania zomrelo 157 z 228 účastníkov konzervatívnej vetvy, teda 69 %, a 136 z 217 účastníkov dialyzačnej vetvy, teda 63 %. Ide o pozorované podiely, nie o samostatný upravený odhad účinku na mortalitu. Primárny výsledok QALY neoprávňuje tvrdiť, že sa preukázala rovnaká mortalita. Ani priemerné sledovanie 4,5 roka neznamená, že priemerné prežívanie účastníkov bolo 4,5 roka. [1]

Komplikácie a hranice istoty

Autori uvádzajú podobné miery hospitalizácií v oboch vetvách. Pri komplikáciách dialyzačného prístupu bol upravený pomer incidenčných mier 0,41 s 95 % intervalom spoľahlivosti od 0,19 do 0,88 v prospech konzervatívnej stratégie. Odhad vychádzal zo 74 udalostí u 36 účastníkov naprieč oboma vetvami. Konkrétne ukazovatele poškodenia neboli vopred špecifikované; tento výsledok preto treba chápať ako doplňujúci. Nedokazuje celkovú bezpečnostnú prevahu konzervatívnej liečby. [1]

Zo 6 120 posudzovaných pacientov bolo vhodných na zaradenie a súhlasilo s randomizáciou 445, približne 7 %. Tento údaj zahŕňa súčasne splnenie kritérií aj ochotu zúčastniť sa. Neznamená, že zvyšných 93 % odmietlo dialýzu. Výber účastníkov, otvorený dizajn a doplňanie chýbajúcich hodnôt EQ-5D-5L u žijúcich pacientov sú dôležité pri posudzovaní prenosnosti a neistoty výsledku. [1]

Ako výsledky zapadajú do ďalších dôkazov

Metaanalýza 22 kohortových štúdií s 21 344 pacientmi zistila asociáciu voľby dialýzy s nižšou mortalitou. Súhrnný upravený pomer hazardov z 12 štúdií bol 0,47 s 95 % intervalom spoľahlivosti od 0,39 do 0,57. Pacienti voliací dialýzu však bývali mladší, menej krehkí a menej zaťažení komorbiditami. Samotní autori upozornili na významné skreslenie a nemožnosť preniesť súhrnný výsledok na konkrétneho pacienta. [4]

Americká observačná štúdia s emuláciou cieľového skúšania porovnala u 20 440 starších pacientov začatie dialýzy do 30 dní s pokračovaním medikamentóznej starostlivosti pri eGFR pod 12 ml/min/1,73 m². Za tri roky bol rozdiel priemerného prežívania 9,3 dňa, s 95 % intervalom spoľahlivosti od -17,4 do 30,1 dňa, a začatie dialýzy sa spájalo s menším počtom dní doma. Pokračovanie medikamentóznej liečby pritom umožňovalo neskoršie začatie dialýzy. [5]

Pri odlišnej analýze, ktorá porovnávala začatie dialýzy s jej úplným vynechaním, bol odhadovaný rozdiel prežívania 77,6 dňa v prospech dialýzy, opäť za cenu menšieho počtu dní doma. Rozdiely medzi týmito analýzami ukazujú, prečo nemožno zamieňať odklad dialýzy, rozhodnutie dialýzu vôbec nezačať a randomizáciu prípravy liečebnej stratégie. Štúdia zostáva observačná, s možným reziduálnym skreslením a obmedzenou prenosnosťou mimo populácie amerických veteránov. [5]

Systematický prehľad kvality života a príznakov pred publikovaním Prepare for Kidney Care našiel iba observačné porovnania. Naznačoval, že u vybraných starších pacientov môže konzervatívna starostlivosť dosahovať podobné pacientom hodnotené výsledky ako dialyzačná stratégia, ale upozorňoval na heterogenitu a skreslenie výberom. Nová randomizovaná práca rozširuje tieto dôkazy, nerobí však zo všetkých konzervatívnych programov navzájom zameniteľnú intervenciu. [7]

Konzervatívna starostlivosť je aktívna liečba

Konzervatívna starostlivosť pri zlyhaní obličiek zahŕňa liečbu príznakov a komplikácií, primerané opatrenia na ochranu zostávajúcej funkcie obličiek a podporu pacienta aj blízkych. Ciele sa prispôsobujú tomu, čo pacient považuje za podstatné. Nemá sa zamieňať s neprístupnosťou liečby ani s ukončením nefrologickej starostlivosti. Podporná starostlivosť má širší význam a patrí aj pacientom, ktorí dialýzu dostávajú. [3]

Výsledok štruktúrovaného programu nemožno používať na zdôvodnenie starostlivosti bez dostupnej kontroly príznakov, pravidelného hodnotenia a nadväznosti na komunitné či paliatívne služby. Ak má byť konzervatívna stratégia skutočnou voľbou, musí mať aj konkrétny plán sledovania, riešenia zhoršenia stavu a podpory rodiny. [2, 3]

Čo sa mení pri rozhovore s pacientom

KDIGO 2024 odporúča rozhodovať o začatí dialýzy podľa súhrnného posúdenia príznakov, klinických známok, kvality života, preferencií, glomerulovej filtrácie a laboratórnych odchýlok. Samotná eGFR pod 15 ml/min/1,73 m² nie je automatickým pokynom na začatie dialýzy. Medzi klinické dôvody na jej začatie patria napríklad prejavy urémie, farmakologicky nezvládnuteľné poruchy vnútorného prostredia alebo neschopnosť kontrolovať objemový stav. [6]

Pri plánovanom rozhodovaní treba pacientovi predstaviť obe možnosti, ich očakávaný prínos, záťaž a neistotu. Rozhovor má zohľadniť funkčný stav, symptómy, komorbidity, podporu blízkych a to, či pacient uprednostňuje dĺžku života, sebestačnosť alebo čo najviac času doma. KDIGO výslovne podporuje konzervatívnu starostlivosť ako možnosť pre ľudí, ktorí si nezvolia náhradu funkcie obličiek. [3, 6]

Prepare for Kidney Care podporuje skoré a opakovane prehodnocované spoločné rozhodovanie u populácie podobnej účastníkom štúdie. Nepodporuje plošné odmietanie dialýzy podľa veku, odklad urgentne potrebnej liečby ani ukončovanie už zavedenej dialýzy na základe tohto výsledku. Jeho klinická hodnota spočíva v presnejšom rozhovore o dvoch dostupných stratégiách, bez sľubu rovnocenného výsledku pre každého pacienta. [1, 2, 6]

Zdroje

1. Fergus J Caskey, Jo Worthington, Yumeng Liu, Stephanie J MacNeill, Leila Rooshenas, Kirsty Garfield, Jessica Frost, Alexandra Soundy, Helen Winton, Karen Alloway, Yoav Ben-Shlomo, Áine Burns, Joseph Chilcot, Jos Darling, Simon J Davies, Ken Farrington, Andy Gibson, Barnaby Hole, Samantha Husbands, Rachel Johnson, Richard Huxtable, Emma Murphy, Fliss E M Murtagh, Yuta Nakano, Hugh Rayner, Caoimhe T Rice, Paul Roderick, Lucy E Selman, Jodi Taylor, Alba X Realpe, Chris Salisbury, Joanna Coast, Jenny L Donovan, J Athene Lane. Preparing for responsive management versus renal dialysis in older people living with kidney failure and frailty or multimorbidity in the UK (Prepare for Kidney Care): a two-arm, superiority, parallel-group, open-label, pragmatic, phase 3, individually randomised controlled trial. Lancet (London, England). 2026 Nov 04; online pred zaradením do čísla. DOI: 10.1016/S0140-6736(26)01818-0. PubMed, PMID 42982076. Vydavateľ.

2. Jo Worthington, Alexandra Soundy, Jessica Frost, Leila Rooshenas, Stephanie J MacNeill, Alba Realpe Rojas, Kirsty Garfield, Yumeng Liu, Karen Alloway, Yoav Ben-Shlomo, Aine Burns, Joseph Chilcot, Jos Darling, Simon Davies, Ken Farrington, Andrew Gibson, Samantha Husbands, Richard Huxtable, Helen McNally, Emma Murphy, Fliss E M Murtagh, Hugh Rayner, Caoimhe T Rice, Paul Roderick, Chris Salisbury, Jodi Taylor, Helen Winton, Jenny Donovan, Joanna Coast, J Athene Lane, Fergus J Caskey. Preparing for responsive management versus preparing for renal dialysis in multimorbid older people with advanced chronic kidney disease (Prepare for Kidney Care): Study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2024 Oct 17; 25(1):688. DOI: 10.1186/s13063-024-08509-8. PubMed, PMID 39420412. Vydavateľ. PubMed Central.

3. Sara N Davison, Wolfgang Pommer, Mark A Brown, Claire A Douglas, Samantha L Gelfand, Irmingarda P Gueco, Barnaby D Hole, Sumiko Homma, Rümeyza T Kazancıoğlu, Harumi Kitamura, Sahar H Koubar, Rene Krause, Kelly C Li, Aoife C Lowney, Shankar P Nagaraju, Abdou Niang, Gregorio T Obrador, Yoichi Ohtake, Jane O Schell, Jennifer S Scherer, Brendan Smyth, Kaichiro Tamba, Nandini Vallath, Nicola Wearne, Elena Zakharova, Carlos Zúñiga, Frank P Brennan. Conservative kidney management and kidney supportive care: core components of integrated care for people with kidney failure. Kidney international. 2024 Jan; 105(1):35-45. DOI: 10.1016/j.kint.2023.10.001. PubMed, PMID 38182300. Vydavateľ. PubMed Central.

4. Carlijn G N Voorend, Mathijs van Oevelen, Wouter R Verberne, Iris D van den Wittenboer, Olaf M Dekkers, Friedo Dekker, Alferso C Abrahams, Marjolijn van Buren, Simon P Mooijaart, Willem Jan W Bos. Survival of patients who opt for dialysis versus conservative care: a systematic review and meta-analysis. Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association. 2022 Jul 26; 37(8):1529-1544. DOI: 10.1093/ndt/gfac010. PubMed, PMID 35195249. Vydavateľ. PubMed Central.

5. Maria E Montez-Rath, I-Chun Thomas, Vivek Charu, Michelle C Odden, Carolyn D Seib, Shipra Arya, Enrica Fung, Ann M O'Hare, Susan P Y Wong, Manjula Kurella Tamura. Effect of Starting Dialysis Versus Continuing Medical Management on Survival and Home Time in Older Adults With Kidney Failure : A Target Trial Emulation Study. Annals of internal medicine. 2024 Sep; 177(9):1233-1243. DOI: 10.7326/M23-3028. PubMed, PMID 39159459. Vydavateľ. PubMed Central.

6. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney international. 2024 Apr; 105(4S):S117-S314. DOI: 10.1016/j.kint.2023.10.018. PubMed, PMID 38490803. Vydavateľ.

7. Wouter R Verberne, Iris D van den Wittenboer, Carlijn G N Voorend, Alferso C Abrahams, Marjolijn van Buren, Friedo W Dekker, Brigit C van Jaarsveld, Ismay N van Loon, Simon P Mooijaart, Gurbey Ocak, Johannes J M van Delden, Willem Jan W Bos. Health-related quality of life and symptoms of conservative care versus dialysis in patients with end-stage kidney disease: a systematic review. Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association. 2021 Jul 23; 36(8):1418-1433. DOI: 10.1093/ndt/gfaa078. PubMed, PMID 32535622. Vydavateľ.

8. University of Bristol. Dialysis may not be the default treatment for older kidney patients. News-Medical. 4. novembra 2026. Sekundárna správa. Východiskový zdroj. DOI a PMID na stránke neuvedené.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=dialyza-konzervativna-starostlivost-starsi-prepare-kidney-care · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.